INSTRUMENTUL 5 / 5

Radarul Erorilor de Planificare

Vezi erorile care prelungesc cazul încă înainte de lipirea bracketilor: 20 de erori în șapte grupe, fiecare cu simptom, cauză și prevenție.

CAPITOLUL 1

20 de Erori de Planificare

Parcurge rândurile: recunoaște simptomul, înțelege de ce consumă timp și trece prevenția în plan.

> *Majoritatea erorilor care prelungesc tratamentul nu încep în mecanică, ci în planificare. O eroare prinsă înainte de bracket economisește luni.*

1 · Diagnostic

EROARE	SIMPTOM	DE CE PRELUNGEȘTE	PREVENȚIE
01 Omiterea alunecării funcționale	La jumătatea tratamentului ocluzia „se schimbă"; revine ocluzia inversă frontală sau Clasa a III-a.	Lucrezi spre un obiectiv sagital și transversal greșit; planul se schimbă la jumătatea drumului.	Verifică în relație centrică; notează diferența RC–IM (Instrumentul 3).
02 Dinte absent, inclus sau supranumerar nevăzut pe panoramică	Caninul nu erupe, spațiul nu se închide, numărul dinților nu se potrivește.	Planul mecanic și de extracție o ia de la capăt; e nevoie de timp chirurgical suplimentar.	Parcurgere completă cu Instrumentul 1; la situații incerte, imagistică suplimentară.
03 Neînregistrarea stării radiculare inițiale	Pe panoramica intermediară apar rădăcini scurte sau resorbție, de cauză necunoscută.	Reduci forțele, tratamentul stagnează; obiectivul se restrânge.	Marchează de la început rădăcinile scurte, bonte și dilacerate; la dinții cu risc, forță ușoară și control intermediar.
04 Planifici doar dinții, nu și fața	Dinții se aliniază, dar profilul sau buzele se înrăutățesc.	Obiectivul trebuie rescris; se schimbă decizia de extracție sau de ancoraj.	Pe lista de probleme scrie întâi fața; decide pe baza fotografiilor de profil și de zâmbet.

2 · Spațiu

EROARE	SIMPTOM	DE CE PRELUNGEȘTE	PREVENȚIE
05 Analiza spațiului fără analiza Bolton	La finisare rămâne un spațiu sau overjet-ul nu se închide.	Finisarea durează cu săptămâni mai mult; stripping sau restaurare ulterioară.	Calculează Bolton de la început; trece stripping-ul sau restaurarea în etapa 2.
06 Amânarea deciziei de extracție	„Începem și vedem”; incisivii merg înainte, apoi înapoi.	Mișcarea dublă consumă timp și crește riscul de resorbție radiculară.	Decide cu Harta de Decizie (Instrumentul 2) încă înainte de bracket.
07 Câștig de spațiu prin expansiune excesivă în zona caninilor	Arcadă mai lată, gingie mai subțire; după contenție înghesuirea revine.	Recidiva înseamnă retratament; se asociază și probleme parodontale.	Nu lărgi distanța intercanină; la necesar mare de spațiu, extracție sau distalizare.

3 · Ancoraj

EROARE	SIMPTOM	DE CE PRELUNGEȘTE	PREVENȚIE
08 Necesarul de ancoraj nu este calculat	La închiderea spațiilor molarii alunecă anterior, overjet deschis, Clasa a II-a se accentuează.	Pierderea de ancoraj trebuie recuperată; mecanica se prelungește.	Ancoraj minim / moderat / maxim în etapa 2; alege dispozitivul dinainte.
09 Introducerea târzie a mini-implantului	Pierderea de ancoraj iese la iveală la închiderea spațiilor.	Distanța pierdută trebuie recâștigată; vizite și timp în plus.	La ancoraj maxim, mini-implantul trebuie să fie în plan de la început.
10 Necesar asimetric de ancoraj neobservat	Pe o parte rămâne Clasa I, pe cealaltă Clasa a II-a; linia mediană deviază.	Finisarea cere elastice asimetrice și mecanică suplimentară.	Notează separat relația molar–canin dreapta și stânga; planifică ancorajul pe fiecare parte.

4 · Vertical

EROARE	SIMPTOM	DE CE PRELUNGEȘTE	PREVENȚIE
11 Mecanica de extruzie la pacienții hiperdivergenți	Crește ocluzia deschisă, rotația posterioară a mandibulei, se alterează profilul.	Controlul vertical necesită aparat suplimentar și timp.	Verifică FMA; limitează utilizarea elasticelor de Clasa II și extruzia molară.
12 Corecția sagitală înainte de deschiderea ocluziei adânci	Bracketurile inferioare se desprind, overjet-ul nu se închide.	Desprinderile și rebonding-ul întârzie tratamentul.	Mai întâi curba Spee și deschiderea ocluziei adânci, apoi corecția sagitală.

5 · Transversal

EROARE	SIMPTOM	DE CE ÎNTÂRZIE	PREVENȚIE
13 Rezolvarea îngustării osoase prin expansiune dentară	Dinți posteriori înclinați vestibular, ocluzie inversă recidivantă.	Pierderea torque-ului și recidiva necesită retratament.	Caută cauza îngustării; dacă este osoasă, RME în funcție de starea suturii.
14 Amânarea expansiunii după aliniere	Expansiunea cu arcada durează luni de zile.	Alinierea și expansiunea trebuie făcute succesiv, nu paralel.	Plasează expansiunea la începutul tratamentului.

6 · Mecanică

EROARE	SIMPTOM	DE CE ÎNTÂRZIE	PREVENȚIE
15 Detectarea tardivă a erorilor de poziționare a bracketurilor	Multe îndoiri la finalizare, paralelism radicular deficitar.	Finalizarea se prelungește; repoziționarea se face târziu.	Verifică paralelismul radicular pe OPG-ul intermediar; repoziționează devreme.
16 Săritul peste etapele secvenței de arcuri	Arc gros sau torque prea devreme; bracketul se desprinde, rotația persistă.	Desprinderile și regresul întârzie timpul de tratament.	Aliniază cu NiTi, apoi oțel; planifică etapa de torque și TMA.
17 Lăsarea rotațiilor și a torque-ului pentru finalizare	Se acumulează multe corecții pentru ultimele luni.	Finalizarea durează mai mult decât era prevăzut.	Tratează rotațiile în faza de aliniere, iar torque-ul înainte de închiderea spațiilor.

7 · Complianța pacientului

EROARE	SIMPTOM	DE CE ÎNTÂRZIE	PREVENȚIE
18 **Plan bazat pe complianță, fără testare**	Nu poartă elasticele sau aparatul în mod regulat.	Corecția sagitală stagnează; planul se modifică.	Măsoară în prima lună; dacă e nevoie, schimbă cu soluții care nu necesită complianță (mini-implant, aparat funcțional fix).
19 **Lipsa criteriilor de igienă orală**	Pete albe, hiperplazie gingivală, desprinderea bracketurilor.	Tratamentul stagnează; se pune problema decimentării premature.	Criterii de igienă și instruire înainte de colarea bracketurilor; verificare la fiecare control.
20 **Durata și contenția nu sunt discutate**	Pacientul ratează programări, dorește finalizarea prematură.	Apar pauze; cere decimentarea înainte de atingerea obiectivelor.	Explică etapele, timpul estimat și planul de contenție la prima consultație.

MODULUL 2

Înainte de Bracketuri: Ultima Verificare

Printează; bifează pentru fiecare caz înainte de programarea pentru colarea bracketurilor.

Pacient / dată

Diagnostic

- [ ] Relație centrică verificată; derapajul funcțional înregistrat
- [ ] Radiografie panoramică (OPG) analizată complet cu Instrumentul 1; starea rădăcinilor înregistrată
- [ ] Profilul și zâmbetul incluse în lista de probleme

Spațiu și ancoraj

- [ ] Analiza de spațiu și analiza Bolton calculate
- [ ] Decizia de extracție luată (Instrumentul 2)
- [ ] Necesarul de ancoraj și mijloacele sale descrise; dacă este necesar mini-implant, este inclus în plan
- [ ] Obiectivele pentru molari și canini (stânga/dreapta) descrise separat

Vertical și transversal

- [ ] Riscul de extruzie evaluat pe baza FMA
- [ ] Deschiderea ocluziei adânci înainte de corecția sagitală
- [ ] Sursa problemei transversale determinată; expansiunea la începutul tratamentului

Mecanică

- [ ] Secvența de arcuri și ordinea etapelor descrise (Instrumentul 4)
- [ ] Data pentru radiografia panoramică (OPG) intermediară stabilită

Pacient

- [ ] Criteriile de igienă orală îndeplinite
- [ ] Aparatele care necesită complianță, durata și contenția explicate

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și avizul de specialitate.

Pasul următor

Deschide tema erorii marcate pe radar în capitolul **Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică**. Pentru a vedea cum arată aceleași erori în cazuri reale, consultă materialul **Modulul 09 · Cazuri Clinice Comentate**.